随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.概念 当血尿必备且突出时,考虑 ①急性肾小球肾炎②急进性肾小球肾炎③慢性肾小球肾炎急性发作

滤的过
①**血尿（＞3/HP）**：必备且突出 没有血尿不可能是急性肾炎综合征　首先想到肾病综合征 但也不能排除急性肾炎综合征
②**蛋白尿（＞0.15g/d）**：可伴有轻、中度蛋白尿，少数可呈肾病综合征范围的蛋白尿(+++)

滤不过
③**水肿**：主要是**肾小球滤过率↓致水钠潴留**。水肿多从**眼睑颜面部开始**（憋出来的），RAAS 被抑制
结构疏松　血容量↑
④**高血压**：主要是水钠潴留（容量依赖型高血压）

3.可有一过性或明显肾功能不全 不属于急性肾炎综合征的含义
①尿量↓（＜400ml/d 为少尿、＜100ml/d 为无尿）
②血 Cr 和 BUN↑
③贫血：**肾产生 EPO 减少**、毒素抑制骨髓造血

一般:以3个月划分急慢性炎症
特殊:病毒性肝炎,肾盂肾炎以6个月划分急慢性

（三）慢性肾炎综合征

与急性肾炎综合征区别
①强调时间,>3个月
②不强调血尿必备且突出

（**血尿、蛋白尿、水肿、高血压＞3 个月**）

血尿、蛋白尿	滤过屏障受损　纤维化　VS急性肾炎综合征RAAS被抑制
水肿、高血压	①**水钠潴留（主要）：肾组织缺血→RAAS 和交感系统激活；肾小球滤过率↓** ②肾实质受损→前列腺素、缓激肽等舒血管物质生成↓ ③心房钠尿肽↓(排水排钠、舒张血管)-与RAAS系统拮抗
多尿、夜尿、低比重尿 首先想到肾小管,后不能忽略肾小球	部分肾小球损害后、血液只能经残存的肾小球滤过，因此滤过速度过快、导致肾小管来不及重吸收水、尿浓缩功能下降 VS 肾盂肾炎:肾小管浓缩功能↓
尿量↓、血 Cr 和 BUN↑、贫血	

（四）肾病综合征 临床类型

1.主要见于：**脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化** 病理类型
必有血尿

2.概念 题目告诉一项大量蛋白尿/低蛋白血症时,优先考虑肾病综合征,但不能除外肾炎综合征
①**大量蛋白尿（必备）**：定性多+++及以上、或**＞3.5**g/d
②**低蛋白血症（必备）**：白蛋白**＜30**g/L。**肝代偿增加**白蛋白合成的能力＜丢失和分解的蛋白质
③**明显水肿** 血浆胶渗压↓
④**高脂血症**（《病理学》高脂血症和脂尿）：高甘油三酯主要与甘油三酯分解减少有关；高胆固醇主要与肝脏合成过多 LDL-C 和 LDL 清除减少有关
肝脏代偿合成蛋白质
不强调高血压

《诊断学》：肾源性水肿举例

肾病综合征（**肾病性水肿**）	急性肾炎综合征（**肾炎性水肿**）
主要：大量蛋白尿造成低蛋白血症致**血浆胶渗压↓** 次要：①有效循环血量↓激活 RAAS→**醛固酮和抗利尿激素↑**→小管重吸收水钠增多致水钠潴留；②原发于远端肾单位的水钠潴留因素	主要：**肾小球滤过率↓致水钠潴留** （肾小管重吸收功能基本正常-球管失衡）问题在于肾小球 次要：高血压和超敏反应引起毛细血管通透性增高
激活 RAAS	**抑制 RAAS（血容量增加）**
水肿多从下肢开始（锁不住水）、或从眼睑颜面部开始	**水肿多从眼睑颜面部开始**（憋出来的）
肾素依赖性高血压（不常见）：进展慢、不会出现血压骤然升高所致的高血压脑病	容量依赖型高血压：进展快、可有血压突然升高所致的高血压脑病